QCM de révision

60 questions · Corrigés regroupés à la fin

Santé publique et déterminants

Q01 **Quels éléments caractérisent la santé publique ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. La santé physique, mentale et sociale.
- ☐ B. L'exclusion des conditions de vie.
- ☐ C. Le seul traitement individuel des infections.
- ☐ D. Une action collective et concertée.
- ☐ E. La seule organisation hospitalière.

Q02 **Quels exemples sont des déterminants de santé ? (3 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Uniquement un médicament prescrit.
- ☐ B. Le soutien de l'entourage.
- ☐ C. Uniquement une maladie diagnostiquée.
- ☐ D. Les revenus.
- ☐ E. Les conditions de logement.

Q03 **Quelles propositions décrivent les fonctions de santé publique ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. La surveillance de l'état de santé.
- ☐ B. La seule réalisation des actes techniques.
- ☐ C. La protection en cas de menace.
- ☐ D. La suppression du rôle préventif.
- ☐ E. La promotion de la santé.

Q04 **Une canicule menace la santé d'une population. Quelle fonction décrit le mieux la réponse de protection face à cette menace ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. La seule rééducation individuelle.
- ☐ B. Une action extérieure à la santé publique.
- ☐ C. La protection des populations en cas de menace.
- ☐ D. La seule prévention quaternaire.
- ☐ E. La seule mesure d'une glycémie.

Q05 Moyen

Comment interpréter une faible espérance de vie à la naissance dans une population historique ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Elle prouve que tous les adultes mouraient au même âge.
- [ ] B. Elle est indépendante des décès d'enfants.
- [ ] C. Elle ne signifie pas que personne n'atteignait un âge avancé.
- [ ] D. Elle correspond à l'âge maximal atteint.
- [ ] E. Une forte mortalité infantile peut abaisser cette moyenne.

Q06 Moyen

Pourquoi la prévention et la promotion de la santé occupent-elles une place croissante dans la réponse aux besoins de santé ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Elles peuvent limiter la demande future de soins curatifs.
- [ ] B. Seuls les médecins sont concernés.
- [ ] C. Les maladies chroniques prennent une place importante.
- [ ] D. Les soins curatifs deviennent toujours inutiles.
- [ ] E. Les conditions de vie n'ont plus d'influence.

Niveaux de prévention

Q07 Facile

La prévention porte sur quels événements ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Uniquement les infections.
- [ ] B. Les maladies.
- [ ] C. Les accidents.
- [ ] D. Les handicaps.
- [ ] E. Uniquement les complications hospitalières.

Q08 Facile

Une intervention cherche à empêcher l'apparition d'une maladie chez une personne qui ne l'a pas. Quel est son niveau ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Aucun niveau de prévention.
- [ ] B. Tertiaire.
- [ ] C. Secondaire.
- [ ] D. Primaire.
- [ ] E. Quaternaire.

Q09 **Quels exemples illustrent une prévention primaire de la maladie visée ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Accompagner l'arrêt du tabac pour prévenir un cancer.
- ☐ B. Réduire une exposition avant l'apparition de la maladie.
- ☐ C. Rééduquer les séquelles d'un AVC connu.
- ☐ D. Rechercher un cancer déjà possible par dépistage.
- ☐ E. Vacciner pour prévenir l'infection concernée.

Q10 **Un dépistage recherche une maladie qui peut être présente sans que la personne le sache. Quelle logique domine ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Tertiaire parce que tout dépistage suit un diagnostic.
- ☐ B. Aucune, car la personne se sent bien.
- ☐ C. Primaire parce que la personne n'a pas de symptômes.
- ☐ D. Quaternaire parce que le test est précoce.
- ☐ E. Secondaire.

Q11 **Quels sont les objectifs de la prévention secondaire ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Prouver qu'une maladie ne peut jamais être silencieuse.
- ☐ B. Permettre une prise en charge plus précoce.
- ☐ C. Limiter la gravité de la maladie repérée.
- ☐ D. Détecter précocement une maladie possible.
- ☐ E. Remplacer toute prévention primaire.

Q12 **Chez une personne dont le diabète est connu, une surveillance des pieds vise à éviter des lésions et leurs complications. Quel niveau décrit cet objectif ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. Universelle comme niveau temporel.
- ☐ B. Primaire du diabète.
- ☐ C. Tertiaire.
- ☐ D. Secondaire du diabète uniquement parce qu'on recherche une lésion.
- ☐ E. Quaternaire uniquement parce qu'une surveillance est réalisée.

Q13 Moyen

Quelles actions relèvent d'une logique tertiaire dans les situations décrites ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Rééducation pour limiter les séquelles d'un AVC.
- [ ] B. Prévention des escarres chez une personne alitée.
- [ ] C. Soutien pour limiter les conséquences d'une maladie connue.
- [ ] D. Dépistage d'un cancer encore non reconnu.
- [ ] E. Vaccination avant la maladie visée.

Q14 Moyen

Pourquoi une neuropathie peut-elle compliquer la surveillance des pieds d'une personne diabétique ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Elle transforme automatiquement l'action en prévention universelle.
- [ ] B. Elle garantit l'absence de toute plaie.
- [ ] C. Elle signifie que le diabète est forcément inconnu.
- [ ] D. Elle rend toute surveillance inutile.
- [ ] E. Une lésion peut être moins bien perçue.

Q15 Facile

Quel objectif définit le mieux la prévention quaternaire ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Éviter des soins inutiles ou disproportionnés.
- [ ] B. Augmenter systématiquement le nombre d'examens.
- [ ] C. Empêcher uniquement une première infection.
- [ ] D. Refuser tout soin à une personne âgée.
- [ ] E. Remplacer toute réflexion collective.

Q16 Moyen

Dans l'exemple d'une rhinite virale, pourquoi l'absence de prescription d'antibiotique illustre-t-elle le juste soin ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Elle correspond à un abandon de toute prise en charge.
- [ ] B. Elle prouve que les antibiotiques ne sont jamais utiles.
- [ ] C. Elle garantit l'absence de toute gêne.
- [ ] D. Le cours n'attend pas de bénéfice de l'antibiotique dans cet exemple.
- [ ] E. Elle évite une exposition inutile aux effets indésirables.

Q17 Difficile

Une équipe discute si une intervention lourde apporte un bénéfice suffisant à une personne très fragile. Quelles propositions sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les bénéfices et risques attendus sont mis en regard.
- ☐ B. L'âge seul impose automatiquement la décision.
- ☐ C. La quaternaire oblige à cesser tout soin.
- ☐ D. La réflexion relève du juste soin.
- ☐ E. Une discussion pluridisciplinaire est exclue.

Q18 Difficile

Quelles associations sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Maladie connue et rechutes à limiter : tertiaire.
- ☐ B. Soin inutile à éviter : secondaire uniquement.
- ☐ C. Complications d'une maladie connue à limiter : primaire de cette même maladie.
- ☐ D. Maladie visée absente et risque à réduire : primaire.
- ☐ E. Maladie possible non reconnue à repérer tôt : secondaire.

Échelle et population

Q19 Facile

Une protection solaire est adaptée au phototype et à la situation d'une personne. À quelle échelle cette mesure est-elle décrite ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Quaternaire comme échelle.
- ☐ B. Universelle comme seule échelle.
- ☐ C. Intersectorielle par définition.
- ☐ D. Collective uniquement parce que plusieurs personnes peuvent le faire.
- ☐ E. Individuelle.

Q20 Moyen

Quelles mesures sont collectives dans les exemples suivants ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Un conseil personnalisé à un seul patient.
- ☐ B. Un bilan adapté au seul risque personnel d'un patient.
- ☐ C. Une campagne de vaccination organisée pour une population.
- ☐ D. Un programme de dépistage organisé.
- ☐ E. Une protection choisie par une seule personne pour elle-même.

Q21 **Dans le classement de Gordon, à qui s'adresse la prévention universelle ? (1 bonne réponse)**

Facile

- [ ] A. À l'ensemble d'une population sans distinction du risque individuel.
- [ ] B. À un seul individu choisi selon son risque.
- [ ] C. Seulement aux personnes déjà diagnostiquées.
- [ ] D. Uniquement aux nourrissons.
- [ ] E. Uniquement aux professionnels de santé.

Q22 **Quelles propositions définissent la prévention orientée ou sélective ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Elle s'adresse toujours à toute la population sans distinction.
- [ ] B. Elle interdit tout autre classement de la même action.
- [ ] C. Elle est synonyme de tout conseil individuel.
- [ ] D. Elle s'adresse à un groupe plus exposé que la moyenne.
- [ ] E. Elle peut prendre la forme d'une campagne collective.

Q23 **La surveillance est individualisée pour un patient présentant des facteurs de risque identifiés. Quel terme de Gordon correspond à cette description ? (1 bonne réponse)**

Facile

- [ ] A. Primaire comme catégorie de Gordon.
- [ ] B. Salutogénique comme catégorie de Gordon.
- [ ] C. Collective comme catégorie de Gordon.
- [ ] D. Ciblée ou indiquée.
- [ ] E. Universelle.

Q24 **Une campagne organise une vaccination des nourrissons pour prévenir une infection. Quelles qualifications sont compatibles ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Orientée.
- [ ] B. Primaire.
- [ ] C. Secondaire de l'infection visée.
- [ ] D. Ciblée uniquement parce que la campagne a un public.
- [ ] E. Collective.

Q25 **Un dépistage organisé recherche un cancer possible dans un groupe défini par le programme. Quelles qualifications sont justifiées ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Primaire du cancer recherché.
- [ ] B. Orienté.
- [ ] C. Individuel uniquement parce que chaque test est réalisé sur une personne.
- [ ] D. Collectif.
- [ ] E. Secondaire.

Q26 **Une affiche est visible par tous mais présente une action réservée à un groupe précis. Quelle précaution de raisonnement faut-il prendre ? (1 bonne réponse)**

Moyen

- [ ] A. Conclure toujours à une action indiquée.
- [ ] B. Conclure toujours à une action universelle.
- [ ] C. Ignorer l'objectif de l'intervention.
- [ ] D. Distinguer le public qui voit le message et celui qui bénéficie de l'action.
- [ ] E. Abandonner les trois classifications.

Promotion, Ottawa et éducation

Q27 **Quel est l'objectif central de la promotion de la santé ? (2 bonnes réponses)**

Facile

- [ ] A. Imposer uniquement un comportement par une affiche.
- [ ] B. Développer leurs moyens d'agir.
- [ ] C. Donner aux populations plus de contrôle sur leur santé.
- [ ] D. Remplacer toute participation de la population.
- [ ] E. Limiter la santé au traitement d'une maladie.

Q28 **Quelles dimensions la promotion de la santé associe-t-elle ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. La seule responsabilité personnelle.
- [ ] B. La seule prescription médicamenteuse.
- [ ] C. L'amélioration des conditions sociales et environnementales.
- [ ] D. L'exclusion des personnes malades.
- [ ] E. Le renforcement des capacités individuelles et collectives.

Q29 Moyen

Quels éléments sont des axes de la charte d'Ottawa ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Renforcer l'action communautaire.
- ☐ B. Limiter les services aux seuls soins curatifs.
- ☐ C. Écarter les aptitudes individuelles.
- ☐ D. Élaborer des politiques pour la santé.
- ☐ E. Créer des environnements favorables.

Q30 Moyen

Une équipe hospitalière développe prévention et promotion en complément des soins curatifs. Quel axe d'Ottawa cela illustre-t-il le plus directement ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Classer toute action en prévention tertiaire.
- ☐ B. Supprimer tout soin.
- ☐ C. Renoncer à l'organisation du système.
- ☐ D. Remplacer les professionnels par des affiches.
- ☐ E. Réorienter les services de santé.

Q31 Moyen

Des habitants construisent ensemble un projet local concernant leur santé. Quelles propositions sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'exemple illustre l'action communautaire.
- ☐ B. L'action ne peut jamais être locale.
- ☐ C. Le simple fait de recevoir une publicité aurait exactement le même sens.
- ☐ D. Il existe une participation active de la communauté.
- ☐ E. Les habitants doivent être malades pour participer.

Q32 Facile

Que vise l'éducation pour la santé ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Favoriser des décisions éclairées.
- ☐ B. Garantir qu'une information entraîne immédiatement un changement.
- ☐ C. Développer les connaissances.
- ☐ D. Développer des compétences utiles pour agir.
- ☐ E. Remplacer l'échange par une injonction identique pour tous.

Q33 Moyen

Quelle situation illustre le mieux le passage de l'information à une démarche éducative ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Répéter un slogan sans écouter les contraintes.
- ☐ B. Discuter avec une personne de moyens réalistes d'intégrer la marche à son trajet.
- ☐ C. Écarter le quotidien de la personne.
- ☐ D. Décider que les connaissances ne servent à rien.
- ☐ E. Conclure qu'un message compris suffit toujours.

Q34 **Quelles relations entre prévention et promotion de la santé sont exactes ? (2 bonnes réponses)**

Difficile

- ☐ A. Elles peuvent être présentes dans une même intervention.
- ☐ B. La promotion peut associer capacités et conditions de vie.
- ☐ C. La promotion exclut toute action collective.
- ☐ D. Elles sont nécessairement opposées.
- ☐ E. Toute promotion est exclusivement un dépistage.

Comportements, freins et représentations

Q35 **Qu'est-ce qu'un comportement de santé ? (1 bonne réponse)**

Facile

- ☐ A. Uniquement une mauvaise habitude.
- ☐ B. Un synonyme exclusif de maladie.
- ☐ C. Une donnée génétique uniquement.
- ☐ D. Uniquement une action médicalement prescrite.
- ☐ E. Une conduite qui influence la santé favorablement ou défavorablement.

Q36 **Quels freins peuvent empêcher un changement malgré la connaissance d'un message de santé ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. Aucun : savoir suffit toujours.
- ☐ B. Seulement une absence de volonté, dans tous les cas.
- ☐ C. Des ressources économiques limitées.
- ☐ D. Un manque de soutien social.
- ☐ E. Un environnement peu accessible.

Q37 **Une personne souhaite un dépistage mais ne parvient pas à accéder à un professionnel. Quel type de frein est directement illustré ? (1 bonne réponse)**

Moyen

- ☐ A. Organisationnel, lié à l'accès aux soins.
- ☐ B. Une absence certaine de connaissances.
- ☐ C. Une impossibilité de toute prévention.
- ☐ D. Une preuve d'absence de motivation.
- ☐ E. Un facteur exclusivement génétique.

Q38 — Facile

Quelles caractéristiques définissent un nudge ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le maintien de la liberté de choix.
- [ ] B. Une incitation par l'environnement.
- [ ] C. Une sanction obligatoire.
- [ ] D. Une interdiction générale.
- [ ] E. Un traitement médicamenteux systématique.

Q39 — Moyen

Un magasin place les fruits au premier plan et les desserts sucrés derrière, sans supprimer les options. Quel raisonnement est juste ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'exemple prouve une efficacité chiffrée universelle.
- [ ] B. La situation peut illustrer un nudge.
- [ ] C. La visibilité peut influencer le choix.
- [ ] D. L'environnement ne joue aucun rôle.
- [ ] E. Il s'agit forcément d'une interdiction des desserts.

Q40 — Facile

Que sont les représentations sociales ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Une notion sans influence sur les comportements.
- [ ] B. Uniquement une lésion anatomique.
- [ ] C. Une perception identique pour chaque personne de toute société.
- [ ] D. Des croyances, connaissances et opinions partagées dans un groupe.
- [ ] E. Une donnée indépendante de l'histoire et du contexte.

Q41 — Moyen

Quelles représentations du tabac peuvent coexister ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Un moment de convivialité.
- [ ] B. Un risque de maladie.
- [ ] C. Une signification unique partagée par tous.
- [ ] D. Un marqueur de style ou de maturité.
- [ ] E. Une preuve que les messages sanitaires suffisent toujours.

Q42 — Difficile

Une personne associe le sport à la douleur et à la peur d'être jugée. Quelle démarche permet un accompagnement adapté ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Conclure immédiatement à une mauvaise volonté.
- [ ] B. Supposer qu'elle voit le sport comme le soignant.
- [ ] C. Tenir compte des obstacles vécus.
- [ ] D. Explorer ce que l'activité représente pour elle.
- [ ] E. Imposer une activité identique à tout le monde.

Approches et éthique

Q43 — Facile

Quels niveaux appartiennent à l'approche socio-écologique ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Primaire comme niveau socio-écologique.
- ☐ B. Politiques publiques.
- ☐ C. Interpersonnel.
- ☐ D. Individuel.
- ☐ E. Quaternaire comme niveau socio-écologique.

Q44 — Moyen

Une cantine d'entreprise propose des repas équilibrés. Quels repères sont pertinents ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'approche par milieux de vie.
- ☐ B. Uniquement la génétique individuelle.
- ☐ C. La nécessité d'une maladie diagnostiquée chez tous les usagers.
- ☐ D. L'exclusion de toute dimension environnementale.
- ☐ E. Le niveau organisationnel.

Q45 — Moyen

Quel est le point d'entrée de l'approche par milieux de vie ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. L'exclusion des écoles.
- ☐ B. Le classement des médicaments.
- ☐ C. Uniquement la chambre hospitalière.
- ☐ D. Uniquement les traitements individuels.
- ☐ E. Les lieux où les personnes vivent, apprennent ou travaillent.

Q46 — Moyen

Quelles propositions correspondent au continuum de santé ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Un diagnostic interdit toute participation sociale.
- ☐ B. Une maladie ne résume pas toutes les dimensions de la santé.
- ☐ C. Il n'existe que deux états exclusifs et immuables.
- ☐ D. La santé est toujours acquise une fois pour toutes.
- ☐ E. La santé peut évoluer de manière dynamique.

Q47 **Quelles associations entre approches pathogénique et salutogénique sont exactes ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Salutogenèse : absence obligatoire de toute maladie.
- [ ] B. Prévention : exclusion de tout raisonnement pathogénique.
- [ ] C. Approches pathogénique et salutogénique : complémentaires.
- [ ] D. Salutogenèse : processus conduisant vers la santé.
- [ ] E. Pathogenèse : processus conduisant à la maladie.

Q48 **Quelles situations illustrent des ressources de résistance ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Une raison de supprimer toute prise en charge.
- [ ] B. Un entourage soutenant malgré une maladie chronique.
- [ ] C. Une garantie de disparition du diagnostic.
- [ ] D. Un travail adapté aux capacités de la personne.
- [ ] E. Des ressources psychologiques permettant de faire face.

Q49 **Que décrit une approche intersectorielle de la santé ? (1 bonne réponse)**

Facile

- [ ] A. L'exclusion des inégalités de santé.
- [ ] B. Le refus de considérer l'urbanisme.
- [ ] C. L'intervention exclusive des médecins.
- [ ] D. La collaboration de secteurs comme santé, transports, travail et éducation.
- [ ] E. Une synonymie avec la seule relation infirmier-patient.

Q50 **Quelles questions éthiques faut-il examiner avant une action de santé ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Le risque de stigmatisation du groupe concerné.
- [ ] B. L'accessibilité des messages et moyens proposés.
- [ ] C. Uniquement la bonne intention de l'équipe.
- [ ] D. La place des choix individuels.
- [ ] E. La nécessité d'une réponse identique pour toute situation.

Politiques et mises en situation

Q51 Moyen

Une campagne nutritionnelle générale aide la population à mieux manger pour prévenir des maladies. Quelles qualifications sont compatibles ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Éducation pour la santé.
- [ ] B. Prévention primaire.
- [ ] C. Prévention tertiaire uniquement.
- [ ] D. Prévention universelle.
- [ ] E. Absence de lien avec la promotion de la santé.

Q52 Moyen

Que cherche à faciliter le Nutri-Score lors des achats alimentaires ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La suppression obligatoire de tous les autres produits.
- [ ] B. Un repérage pouvant influencer le comportement.
- [ ] C. Le choix alimentaire par une information visible.
- [ ] D. Le diagnostic d'un cancer chez l'acheteur.
- [ ] E. La garantie qu'un même prix convient à tous.

Q53 Moyen

Une campagne cherche à réduire la stigmatisation des troubles psychiques. Quels mécanismes peuvent y contribuer ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Faciliter la demande d'aide.
- [ ] B. Exclure le travail et la vie sociale.
- [ ] C. Réduire la santé mentale au seul médicament.
- [ ] D. Changer les représentations de la santé mentale.
- [ ] E. Prouver que toute affiche est une action communautaire active.

Q54 Moyen

Le Mois sans tabac encourage des fumeurs à arrêter pour prévenir des maladies liées au tabac. Quelles propositions sont justes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le tabac est ici le cancer déjà diagnostiqué.
- [ ] B. L'action est orientée vers les fumeurs.
- [ ] C. Le soutien collectif peut être mobilisé.
- [ ] D. L'objectif décrit relève de la prévention primaire.
- [ ] E. Toute dimension de motivation est exclue.

Q55 Moyen

Quels leviers sont utilisés dans les politiques antitabac présentées ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Créer des environnements sans tabac.
- ☐ B. Réduire l'attractivité des paquets.
- ☐ C. Agir sur le prix pour dissuader l'achat.
- ☐ D. Garantir le même effet pour chaque personne.
- ☐ E. Se limiter à une information sans action sur le contexte.

Q56 Facile

Quelle période couvre la politique des 1 000 premiers jours ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. De six ans à l'adolescence uniquement.
- ☐ B. Toute la vie adulte sans lien avec la parentalité.
- ☐ C. Du début de la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant.
- ☐ D. Seulement les deux ans précédant la grossesse.
- ☐ E. Uniquement la naissance.

Q57 Difficile

Un entretien postnatal comporte repérage d'une dépression et conseils de parentalité. Quelles analyses sont justifiées ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Les conseils peuvent relever de l'éducation pour la santé.
- ☐ B. Le repérage d'un trouble présent relève d'une logique secondaire.
- ☐ C. L'entretien peut associer plusieurs logiques.
- ☐ D. Toute la consultation est forcément quaternaire.
- ☐ E. Les conseils annulent l'intérêt du repérage.

Q58 Moyen

Dans les actions de santé sexuelle présentées, quelles distinctions sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Tous les moyens de contraception ont nécessairement la même fonction contre les infections.
- ☐ B. Être sexuellement actif constitue en soi un diagnostic de maladie.
- ☐ C. La vaccination vise une prévention primaire de la maladie concernée.
- ☐ D. Informer sur les soins n'a aucun rôle éducatif.
- ☐ E. Le dépistage d'une IST vise une logique secondaire.

Q59 Moyen

Quels objectifs sont associés à l'EVAR et à l'EVARS ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Le respect de soi et des autres.
- ☐ B. La protection contre les violences.
- ☐ C. L'égalité entre filles et garçons.
- ☐ D. Le diagnostic systématique d'IST chez tous les élèves.
- ☐ E. L'exclusion de la notion de consentement.

Q60 **Une action de santé comporte plusieurs composantes. Quelle méthode permet de la classer avec rigueur ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Repérer les leviers et niveaux réellement mobilisés.
- [ ] B. Imposer une seule catégorie même si les objectifs diffèrent.
- [ ] C. Distinguer moment, échelle et population.
- [ ] D. Choisir uniquement à partir du mot « affiche ».
- [ ] E. Préciser son objectif avant de nommer le niveau.

Corrigés argumentés

Santé publique et déterminants

Q01 — Réponses : A, D. A — Vrai. La santé comprend les dimensions physique, mentale et sociale. B — Faux. Les conditions sociales et environnementales influencent la santé. C — Faux. Elle dépasse le traitement individuel et les seules infections. D — Vrai. La santé publique agit à l'échelle des populations. E — Faux. L'organisation des soins est une fonction parmi cinq.

Q02 — Réponses : B, D, E. A — Faux. La notion dépasse les traitements. B — Vrai. Les relations sociales sont un déterminant. C — Faux. Un déterminant n'est pas défini comme une maladie. D — Vrai. Les ressources économiques influencent les possibilités d'action. E — Vrai. Le cadre de vie peut influencer la santé.

Q03 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Elle correspond notamment à la veille sanitaire. B — Faux. Le périmètre est plus large que les actes individuels. C — Vrai. La gestion des crises fait partie des fonctions. D — Faux. La prévention est au contraire une fonction essentielle. E — Vrai. Elle complète prévention, surveillance, protection et organisation.

Q04 — Réponses : C. A — Faux. La situation concerne une menace collective. B — Faux. Une canicule constitue une menace pour la santé de la population. C — Vrai. Les menaces ne sont pas uniquement infectieuses. D — Faux. Le critère décrit ici une fonction de santé publique. E — Faux. Cet acte ne résume pas la réponse à une canicule.

Q05 — Réponses : C, E. A — Faux. Une moyenne ne décrit pas chaque trajectoire individuelle. B — Faux. Ces décès influencent fortement la valeur. C — Vrai. Une moyenne n'est pas une durée maximale de vie. D — Faux. Il s'agit d'un indicateur moyen. E — Vrai. Les décès précoces peuvent fortement abaisser cette moyenne.

Q06 — Réponses : A, C. A — Vrai. Prévenir participe à la réponse aux besoins de santé. B — Faux. Les infirmiers participent aussi à ces actions. C — Vrai. Le vieillissement contribue à modifier les besoins. D — Faux. Prévention et soins restent complémentaires. E — Faux. Leur rôle participe à la réponse aux besoins de santé.

Corrigés argumentés

Niveaux de prévention

Q07 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Son champ est plus large. B — Vrai. Elle vise leur nombre ou leur gravité. C — Vrai. Les accidents font partie de la définition. D — Vrai. Elle vise aussi à éviter ou réduire les handicaps. E — Faux. Elle intervient à différents moments et dans différents milieux.

Q08 — Réponses : D. A — Faux. C'est le principe de la prévention primaire. B — Faux. La tertiaire limite les conséquences d'une maladie connue. C — Faux. La secondaire recherche une maladie déjà possible. D — Vrai. Elle agit avant l'apparition de la maladie visée. E — Faux. La quaternaire concerne le juste soin.

Q09 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Le tabac est ici un facteur de risque de la maladie visée. B — Vrai. On agit sur le risque en amont. C — Faux. L'objectif décrit est tertiaire. D — Faux. L'objectif décrit est secondaire. E — Vrai. L'action cherche à empêcher la maladie.

Q10 — Réponses : E. A — Faux. Le diagnostic de la maladie recherchée n'est pas encore établi. B — Faux. Une maladie peut être silencieuse. C — Faux. L'absence de symptômes ne prouve pas l'absence de maladie. D — Faux. La précocité ne définit pas la quaternaire. E — Vrai. On cherche à détecter tôt pour prendre en charge.

Q11 — Réponses : B, C, D. A — Faux. La logique repose justement sur cette possibilité. B — Vrai. Le but est d'améliorer les possibilités de traitement. C — Vrai. Une intervention précoce peut réduire ses conséquences. D — Vrai. La détection peut précéder les symptômes. E — Faux. Les niveaux sont complémentaires.

Q12 — Réponses : C. A — Faux. Universelle appartient au classement de population. B — Faux. Le diabète est déjà diagnostiqué. C — Vrai. L'action limite les conséquences d'une maladie déjà connue. D — Faux. L'objectif décrit concerne ses complications. E — Faux. Aucun soin inutile n'est mis en balance dans l'énoncé.

Q13 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Elle cherche à limiter les incapacités après une maladie connue. B — Vrai. Elle vise à prévenir des complications d'une maladie déjà connue. C — Vrai. La logique est de réduire ses répercussions. D — Faux. L'objectif présenté est secondaire. E — Faux. L'objectif présenté est primaire.

Corrigés argumentés

Q14 — Réponses : E. A — Faux. Le choix de population est une autre classification. B — Faux. Une sensibilité diminuée ne protège pas des lésions. C — Faux. Le raisonnement porte ici sur un diabète déjà connu. D — Faux. La surveillance aide à repérer les lésions malgré la baisse de sensibilité. E — Vrai. La diminution de sensibilité peut laisser passer une blessure.

Q15 — Réponses : A. A — Vrai. Elle recherche le juste soin. B — Faux. L'accumulation d'actes n'est pas son objectif. C — Faux. Cet objectif correspond à la primaire. D — Faux. Le raisonnement est individualisé, pas fondé sur l'âge seul. E — Faux. Une réflexion pluridisciplinaire peut aider à rechercher le juste soin.

Q16 — Réponses : D, E. A — Faux. Éviter un acte inutile n'est pas abandonner le soin. B — Faux. L'énoncé concerne une situation virale particulière. C — Faux. L'exemple ne promet pas une disparition immédiate des symptômes. D — Vrai. La prescription serait inutile pour l'infection virale décrite. E — Vrai. Le risque compte dans la balance bénéfice-risque.

Q17 — Réponses : A, D. A — Vrai. C'est le cœur du raisonnement présenté. B — Faux. L'exemple ne constitue pas une règle automatique. C — Faux. Elle recherche les soins utiles et proportionnés. D — Vrai. La pertinence de l'intervention est évaluée au cas par cas. E — Faux. Elle est au contraire présentée comme un moyen de réflexion.

Q18 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. On limite ses conséquences et son retour. B — Faux. La logique décrite est quaternaire. C — Faux. La maladie étant connue, la logique présentée est tertiaire. D — Vrai. On agit avant son apparition. E — Vrai. On vise sa détection précoce.

Échelle et population

Q19 — Réponses : E. A — Faux. Quaternaire décrit un objectif de juste soin. B — Faux. Universelle classe la population, pas l'échelle. C — Faux. Aucune collaboration de secteurs n'est décrite. D — Faux. La possibilité de répétition ne change pas l'échelle décrite. E — Vrai. La mesure est adaptée à cette personne.

Q20 — Réponses : C, D. A — Faux. L'action décrite est individuelle. B — Faux. L'échelle décrite est individuelle. C — Vrai. Le dispositif est organisé à l'échelle d'un groupe. D — Vrai. Le programme concerne une population définie. E — Faux. Il s'agit d'une mesure individuelle.

Corrigés argumentés

Q21 — Réponses : A. A — Vrai. C'est le critère de la catégorie universelle. B — Faux. C'est une logique de ciblage selon les risques. C — Faux. L'universel n'est pas défini par un diagnostic. D — Faux. Cet exemple relève d'un groupe particulier. E — Faux. Ce serait une population restreinte, pas la définition générale.

Q22 — Réponses : D, E. A — Faux. Ce serait la définition de l'universel. B — Faux. Les classifications se complètent. C — Faux. Le conseil individuel ne suffit pas à définir une catégorie de groupe. D — Vrai. Le critère est un risque accru dans une population définie. E — Vrai. Collectif et orienté sont compatibles.

Q23 — Réponses : D. A — Faux. Primaire appartient au classement temporel. B — Faux. Il s'agit d'une approche de promotion de la santé. C — Faux. Collective décrit l'échelle. D — Vrai. Le choix est individualisé selon les risques personnels. E — Faux. L'action ne concerne pas toute la population sans distinction.

Q24 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Le groupe d'âge est spécifiquement concerné. B — Vrai. On cherche à empêcher l'infection visée. C — Faux. L'énoncé ne recherche pas une infection déjà présente. D — Faux. Le mot cible au sens courant ne suffit pas pour la catégorie indiquée. E — Vrai. La campagne est organisée pour une population.

Q25 — Réponses : B, D, E. A — Faux. Le dépistage vise une maladie potentiellement présente. B — Vrai. Le programme définit un groupe particulier. C — Faux. L'énoncé demande l'échelle du programme organisé. D — Vrai. L'organisation porte sur une population. E — Vrai. Le dispositif recherche une maladie déjà possible.

Q26 — Réponses : D. A — Faux. Une catégorie individualisée n'est pas prouvée. B — Faux. La visibilité ne définit pas à elle seule les bénéficiaires. C — Faux. L'objectif est nécessaire pour classer. D — Vrai. La diffusion et la population d'intervention peuvent différer. E — Faux. Il faut les appliquer en précisant le critère.

Promotion, Ottawa et éducation

Q27 — Réponses : B, C. A — Faux. L'action dépasse une injonction ou une information isolée. B — Vrai. Le renforcement des capacités fait partie de la démarche. C — Vrai. La charte d'Ottawa relie contrôle et amélioration de la santé. D — Faux. La participation est essentielle. E — Faux. La promotion agit aussi sur les ressources et les conditions de vie.

Corrigés argumentés

Q28 — Réponses : C, E. A — Faux. Les déterminants collectifs participent aussi à la santé. B — Faux. Ce n'est pas la définition de cette démarche. C — Vrai. Le contexte de vie participe aux moyens de santé. D — Faux. Malades et non-malades peuvent participer. E — Vrai. Il permet aux personnes de mieux agir.

Q29 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. Les citoyens participent aux projets de santé. B — Faux. La charte propose leur réorientation vers davantage de prévention. C — Faux. Leur développement est un autre axe. D — Vrai. Les décisions publiques doivent prendre la santé en compte. E — Vrai. Le milieu doit faciliter les comportements favorables.

Q30 — Réponses : E. A — Faux. L'axe ne fixe pas un seul niveau temporel. B — Faux. La réorientation complète les soins curatifs. C — Faux. Les services restent organisés pour les besoins. D — Faux. L'énoncé décrit une évolution de l'activité de l'équipe. E — Vrai. Les services donnent plus de place à ces dimensions.

Q31 — Réponses : A, D. A — Vrai. Les habitants participent activement à un projet concernant leur santé. B — Faux. La situation décrit précisément un projet local. C — Faux. Recevoir un message ne prouve pas une participation active. D — Vrai. Les habitants contribuent aux choix et au projet. E — Faux. La participation n'est pas limitée aux personnes malades.

Q32 — Réponses : A, C, D. A — Vrai. L'autonomie est un objectif. B — Faux. D'autres freins peuvent empêcher l'action. C — Vrai. Informer constitue une première dimension. D — Vrai. La démarche dépasse le simple savoir. E — Faux. L'accompagnement tient compte des personnes et de leur contexte.

Q33 — Réponses : B. A — Faux. L'information seule ne développe pas les moyens d'agir. B — Vrai. L'échange transforme le message en possibilité concrète. C — Faux. C'est au contraire un point d'appui de la démarche. D — Faux. Elles restent une composante de l'éducation. E — Faux. Comprendre et pouvoir agir sont différents.

Q34 — Réponses : A, B. A — Vrai. Les démarches sont complémentaires. B — Vrai. Elle agit sur les moyens de maîtriser les déterminants. C — Faux. Les capacités collectives et la participation en font partie. D — Faux. Prévention et promotion peuvent contribuer à une même action. E — Faux. Le dépistage ne résume pas cette démarche.

Corrigés argumentés

Comportements, freins et représentations

Q35 — Réponses : E. A — Faux. Le comportement peut être favorable. B — Faux. Une conduite et un diagnostic ne sont pas la même notion. C — Faux. Il s'agit d'actions, habitudes ou conduites. D — Faux. Les habitudes du quotidien sont aussi concernées. E — Vrai. La notion ne désigne pas seulement les conduites favorables.

Q36 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Le changement dépend de plusieurs déterminants, au-delà de la connaissance. B — Faux. Cette explication efface les contraintes du contexte. C — Vrai. Le coût peut limiter les possibilités. D — Vrai. L'entourage peut freiner ou faciliter l'action. E — Vrai. La proximité d'équipements ou de services compte.

Q37 — Réponses : A. A — Vrai. La possibilité d'obtenir le service est en cause. B — Faux. L'énoncé n'établit pas ce manque. C — Faux. Il faut analyser et traiter le frein identifié. D — Faux. Le souhait de dépistage est explicite. E — Faux. Il s'agit de l'organisation et de l'accès.

Q38 — Réponses : A, B. A — Vrai. Le nudge ne supprime pas les alternatives. B — Vrai. L'organisation du choix influence la conduite. C — Faux. La définition exclut la sanction. D — Faux. L'incitation se distingue de l'interdiction. E — Faux. Ce n'est pas la définition de l'outil.

Q39 — Réponses : B, C. A — Faux. La situation ne permet pas d'affirmer un taux universel d'efficacité. B — Vrai. L'environnement oriente sans supprimer le choix. C — Vrai. C'est le mécanisme illustré par l'expérience. D — Faux. C'est précisément l'élément modifié. E — Faux. Les desserts restent disponibles.

Q40 — Réponses : D. A — Faux. Elles peuvent orienter les conduites et le recours aux soins. B — Faux. Il s'agit d'une construction de sens. C — Faux. Plusieurs représentations peuvent coexister. D — Vrai. Elles concernent un objet social et son interprétation. E — Faux. Le contexte et les expériences participent à leur construction.

Q41 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. La pause cigarette peut être associée à la sociabilité. B — Vrai. Les atteintes sanitaires constituent une autre représentation. C — Faux. Les représentations du tabac peuvent différer selon les personnes et les contextes. D — Vrai. Certaines images culturelles le valorisent ainsi. E — Faux. Les représentations peuvent compliquer l'accompagnement.

Corrigés argumentés

Q42 — Réponses : C, D. A — Faux. Cela ignore les significations et les contraintes. B — Faux. Les représentations peuvent différer. C — Vrai. Les freins ne se limitent pas au savoir. D — Vrai. Comprendre ses représentations aide à adapter l'échange. E — Faux. L'accompagnement doit considérer la situation.

Approches et éthique

Q43 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Primaire est un niveau temporel de prévention. B — Vrai. Les décisions collectives influencent aussi la santé. C — Vrai. Il concerne l'entourage et les relations. D — Vrai. Il concerne les caractéristiques de la personne. E — Faux. Il décrit la recherche du juste soin.

Q44 — Réponses : A, E. A — Vrai. L'action intervient dans le lieu de travail. B — Faux. L'intervention modifie un contexte concret. C — Faux. Une transformation du milieu n'exige pas ce diagnostic. D — Faux. L'offre alimentaire fait partie de l'environnement. E — Vrai. Le fonctionnement d'une structure est concerné.

Q45 — Réponses : E. A — Faux. L'école est un exemple central. B — Faux. Ce n'est pas l'objet de cette approche. C — Faux. Écoles, villes et travail sont aussi des milieux de vie. D — Faux. Le point d'entrée est le milieu. E — Vrai. L'action rend ces lieux plus favorables à la santé.

Q46 — Réponses : B, E. A — Faux. Les ressources et adaptations peuvent soutenir cette participation. B — Vrai. Des ressources et du bien-être peuvent persister. C — Faux. C'est une vision dichotomique, différente de celle du continuum. D — Faux. Elle peut varier et être soutenue par des actions. E — Vrai. Le continuum s'oppose à une lecture figée en deux cases.

Q47 — Réponses : C, D, E. A — Faux. La démarche intègre les ressources malgré une maladie. B — Faux. Elle recherche ce qui produit ou favorise la santé. C — Vrai. Réduire les risques et renforcer les ressources peuvent s'associer. D — Vrai. L'approche salutogénique cherche les ressources favorables. E — Vrai. L'approche pathogénique cherche ce qui rend malade.

Q48 — Réponses : B, D, E. A — Faux. Ressources et soins peuvent se compléter. B — Vrai. Le soutien social peut aider à préserver la santé. C — Faux. Les ressources ne signifient pas une guérison certaine. D — Vrai. Le contexte professionnel peut soutenir la vie quotidienne. E — Vrai. Cette ressource personnelle peut aider à faire face aux difficultés.

Corrigés argumentés

Q49 — Réponses : D. A — Faux. Réduire les inégalités fait partie des objectifs cités. B — Faux. L'urbanisme peut favoriser ou freiner des comportements. C — Faux. La démarche associe plusieurs secteurs. D — Vrai. Les déterminants dépassent le seul secteur des soins. E — Faux. L'échelle de collaboration dépasse cette relation.

Q50 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. Une norme ou un ciblage peut avoir des effets négatifs. B — Vrai. L'équité fait partie de la réflexion. C — Faux. Les conséquences et les conditions réelles comptent aussi. D — Vrai. Les libertés et l'autonomie doivent être prises en compte. E — Faux. La discussion collective aide à examiner les situations et leurs conséquences.

Politiques et mises en situation

Q51 — Réponses : A, B, D. A — Vrai. La campagne apporte des connaissances utiles. B — Vrai. L'objectif est d'éviter l'apparition de maladies. C — Faux. Aucune maladie connue avec complications n'est précisée. D — Vrai. Le message s'adresse à la population générale. E — Faux. L'information peut contribuer aux moyens d'agir.

Q52 — Réponses : B, C. A — Faux. L'outil d'information ne supprime pas les choix. B — Vrai. L'information nutritionnelle vise à orienter les choix sans supprimer les alternatives. C — Vrai. Il soutient la décision lors des achats. D — Faux. Il ne s'agit pas d'un dépistage. E — Faux. Les contraintes économiques restent distinctes.

Q53 — Réponses : A, D. A — Vrai. Une représentation moins stigmatisante peut favoriser le recours aux soins. B — Faux. Ces dimensions participent à la santé. C — Faux. L'inclusion et les dimensions sociales comptent aussi. D — Vrai. La campagne cherche à lever des tabous. E — Faux. La participation active doit être établie.

Q54 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Le facteur de risque ne se confond pas avec la maladie visée. B — Vrai. Le public concerné est défini par l'exposition. C — Vrai. Le défi partagé peut soutenir la motivation à arrêter. D — Vrai. Les maladies visées sont à prévenir par la réduction du risque. E — Faux. La motivation est un levier explicitement discuté.

Corrigés argumentés

Q55 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Le cadre de vie peut réduire l'exposition et faciliter la santé. B — Vrai. Le paquet neutre agit notamment sur le marketing. C — Vrai. Ce levier modifie les conditions d'achat du tabac. D — Faux. Les réactions peuvent différer. E — Faux. Plusieurs mesures modifient l'environnement ou les conditions d'achat.

Q56 — Réponses : C. A — Faux. Le programme concerne une période plus précoce. B — Faux. L'accompagnement des parents et du développement est central. C — Vrai. Cette politique concerne une période allant de la grossesse aux deux ans de l'enfant. D — Faux. Cette période ne correspond pas aux 1 000 premiers jours. E — Faux. La période commence avant et se prolonge après.

Q57 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Ils développent les capacités des parents. B — Vrai. L'objectif est de reconnaître et orienter précocement. C — Vrai. Le dispositif ne se réduit pas nécessairement à un seul objectif. D — Faux. Aucun soin inutile à éviter n'est décrit. E — Faux. Les deux composantes peuvent se compléter.

Q58 — Réponses : C, E. A — Faux. Il faut distinguer les moyens et les objectifs, sans généralisation. B — Faux. La contraception et la prévention des IST répondent à des objectifs distincts. C — Vrai. Elle agit avant cette maladie. D — Faux. L'information accessible peut contribuer à l'éducation. E — Vrai. On recherche une infection déjà possible.

Q59 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Ces valeurs sont explicitement citées. B — Vrai. Le programme vise aussi cette protection. C — Vrai. Elle fait partie des objectifs annoncés. D — Faux. L'exemple concerne une démarche éducative. E — Faux. L'éducation au consentement participe à la prévention des violences et au respect d'autrui.

Q60 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Une action peut combiner information, milieu et accès aux soins. B — Faux. Distinguer les composantes permet de préciser les objectifs et les publics. C — Vrai. Ces trois critères répondent à des questions différentes. D — Faux. Le support de communication ne définit pas tout le dispositif. E — Vrai. Le but permet de comprendre la logique de prévention.